



Collection MedWIZ

3^e année médecine

PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Parasitologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Introduction à la parasitologie médicale	8				
02	Amibes et amébose	10				
03	Amibes libres	14				
04	Flagellés et ciliés des cavités ouvertes	18				
05	Cryptosporidiose et coccidioses intestinales	20				
06	Leishmanioses	22				
07	Trypanosomes et trypanosomoses	24				
08	Toxoplasmose	26				
09	Paludisme	28				
10	Cestodes parasites à l'état adulte	30				
11	Cestodoses larvaires	32				
12	Distomatoses (Fasciolose à fasciola hepatica)	34				
13	Schistosomoses et bilharzioses	36				
14	Nématodes et nématodoses intestinales	38				
15	Syndrome de larva migrans	42				
16	Filaires et filarioses	44				
17	Notions d'entomologie médicale	48				

II. Mycologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
18	Introduction à la mycologie	52				
19	Candida et candidoses	54				
20	Cryptococcose	56				
21	Malassezia et malassezioses	58				
22	Histoplasmoses	60				
23	Dermatophytes et dermatophyties	62				
24	Aspergillus et aspergilloses	64				
25	Sporotrichose (Maladies des éleveurs de roses)	66				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Parasitologie

© 2026 The WIZ - All rights reserved.

INTRODUCTION À LA PARASITOLOGIE MÉDICALE

I. DÉFINITIONS FONDAMENTALES

- **Parasitologie médicale** : Étude des organismes parasites de l'homme, de leur morphologie, biologie, des affections causées, ainsi que leur diagnostic, traitement et prophylaxie.
- **Parasitisme** : Association permanente ou temporaire où un seul organisme (le parasite) tire profit aux dépens d'un autre (l'hôte).
- **Parasitose** : Maladie causée par un parasite.

II. TYPES D'ASSOCIATIONS BIOLOGIQUES

Type	Définition
Saprophytisme	Organisme se nourrit de matières en décomposition dans le milieu extérieur
Commensalisme	Organisme se nourrit sur un être vivant sans lui nuire
Symbiose	Association mutuellement bénéfique

III. CLASSIFICATION DES PARASITES

A. Selon la localisation

- **Endoparasites** : Vivent à l'intérieur de l'hôte (ex : Ascaris)
- **Ectoparasites** : Vivent à la surface (vecteurs, agents pathogènes, nuisants)

B. Selon le type d'hôte

- **Anthrophile** → Anthroponose (humain → humain)
- **Zoophile** → Anthrozoonose (animal → humain)
- **Géophile** : Vivent dans le sol

C. Selon la mobilité

- Pseudopodes, ventouses, cils, flagelles, membrane ondulante

IV. MODES DE PARASITISME

Mode	Définition	Exemple
Facultatif	Peut vivre libre ou parasite	Acanthamoeba
Obligatoire	Doit vivre dans un hôte	—
Accidentel	Hôte inhabituel, survie temporaire	Larves de mouches
Erratique	Hors localisation habituelle, impasse parasitaire	Kyste hydatique
Opportuniste	Devient pathogène en cas d'immunodépression	Cryptosporidium

V. CLASSIFICATION SCIENTIFIQUE

- **Hiérarchie** : Règne → Embranchement → Classe → Ordre → Famille → Genre → Espèce
- **Exemple** : *Entamoeba histolytica*
 - Règne : Protista
 - Embranchement : Protozoa (unicellulaire)
 - Classe : Rhizopodea (pseudopodes)
 - Ordre : Amoebida
 - Famille : Entamoebidae
 - Genre : Entamoeba
 - Espèce : Entamoeba histolytica
- **Deux règnes d'intérêt** : Champignons et Zooparasites

VI. HÔTES ET RÉSERVOIR

- **Hôte définitif** : Formes adultes / reproduction sexuée
- **Hôte intermédiaire** : Formes larvaires / reproduction asexuée (peut être vecteur)
- **Réservoir** : Être vivant maintenant le parasite dans la nature

VII. CYCLE ÉVOLUTIF

- **Direct ou Indirect** : Suite de transformations d'un adulte fertile aux stades suivants.

VIII. VOIES DE PÉNÉTRATION

Voie	Exemple
Buccale	Amibiase
Transcutanée	Bilharziose
Sexuelle	Trichomonose
Transfusionnelle	Paludisme
Pulmonaire	Mycoses
Vectorielle	Paludisme
Transplacentaire	Toxoplasmose
Grefe d'organe	Toxoplasmose

IX. VOIES DE SORTIE

Fécale • Urinaire • Sécrétion bronchique • Plaie cutanée • Vecteur hématophage

Intérêt : Orientation du diagnostic et mesures prophylactiques

X. ACTIONS DU PARASITE SUR L'HÔTE

1. Spoliatrice (privation nutritive)
2. Toxique
3. Mécanique
4. Traumatique
5. Irritative
6. Allergisante

XI. RÉACTIONS DE L'HÔTE

A. Humorales

- **Prémunition** : Immunité incomplète, résistance à la réinfection

B. Cellulaires

- Phagocytose
- Hyperéosinophilie
- Réactions inflammatoires

Porteur sain : Sans signes cliniques, source de contamination (dépistage important)

XII. TRAITEMENTS

- Curatif
- Symptomatique
- Chirurgical

Exemple : Métronidazole (Flagyl®)

XIII. PROPHYLAXIE

- **Collective** : Protection de la population par rupture du cycle évolutif
- **Individuelle** : Protection du sujet sain

AMIBES ET AMOEBOSE (1)

I. GÉNÉRALITÉS

- Rhizopodes = protozoaires amiboïdes à pseudopodes
- Amibes nues = sans structure périphérique de protection
- Amibes parasites de l'homme : 3 groupes (Entameba, Endolimax, Pseudolimax)
- Seule Entameba histolytica est pathogène → responsable de l'amoébose
- Quelques amibes libres (Acanthameba, Naegleria) peuvent être opportunistes

II. AGENT PATHOGÈNE : ENTAMEBA HISTOLYTICA

A. Formes évolutives :

Forme (Taille)	Taille	Caractéristiques
Histolytica (hématophage)	20-30 μm	Pseudopode unique, effilé ; cytoplasme avec hématies ; pathogène
Minuta (non hématophage)	10-20 μm	Non pathogène ; vit dans la lumière intestinale
Kyste mûr	12-16 μm	4 noyaux ; forme de résistance ; éliminé dans les selles

B. Noyau :

- Caryosome central fin
- Chromatine périphérique en couronne régulière
- Critère taxinomique majeur

III. CYCLE ÉVOLUTIF

1. Contamination : ingestion de kystes (eau, légumes, mains sales, mouches)
2. Dékystement : libération de 8 trophozoïtes minuta dans l'intestin
3. Cycle non pathogène : minuta → multiplication → enkystement → selles
4. Cycle pathogène (conditions favorables) :
 - Minuta → Histolytica (hématophage)
 - Pénètre la paroi intestinale → ulcères
 - Dissémination possible (foie, poumon, cerveau...)
 - Réversion possible sous traitement → minuta → kystes

IV. CLINIQUE

1. Amœbose intestinale

- Dysenterie amibienne :
 - selles glairo-sanglantes ("crachat rectal")
 - épreintes, ténèsme
 - apyrétique
- Colite maligne :
 - gravissime
 - touche femmes enceintes / sujets stressés
 - risque de perforation
- Amébome : tumeur inflammatoire rare
- Colite chronique : troubles du transit, douleurs, asthénie

2. Amœbose hépatique

- Douleur hypochondre droit
- Fièvre 39-40°C
- Hépatomégalie douloureuse
- Abscès du foie → urgence thérapeutique
- Diagnostic différentiel :
 - abcès bactérien
 - cancer
 - cirrhose
 - kyste hydatique

3. Autres localisations

- Pulmonaire (base droite) → secondaire à l'hépatique
- Cérébrale (rare)
- Cutanée
- Génitale
- Péricardique